

尿流改道 — 比较各种选择

WARWIKI

患者须知 · 膀胱切除或失功能后的三种尿液引流方式

当膀胱被切除或无法正常工作时，尿液需要一条新的出路 — 这就是尿流改道。主要有三种方式，均需借助一段自体肠道，最大区别在于日常如何排空尿液：腹壁引流袋、经尿道自然排尿，或使用导尿管。本页对三者进行比较；每种方式另有专页详述。

三种选择

佩戴引流袋

回肠膀胱 (Ileal Conduit)

一小段肠道将尿液引至腹壁的小开口（造口），尿液持续流入轻便引流袋，需定期排空更换。操作最简便、最为常用；无需控制或导尿。

经尿道排尿 · 无需引流袋

原位新膀胱 (Orthotopic Neobladder)

用肠道构建的新储尿囊与尿道相连，可以自然排尿，无需引流袋。需按时间表排尿（白天和夜间），有时需要导尿，初期漏尿较常见。

导尿管排空 · 无需引流袋

可控性皮肤改道 (Indiana Pouch)

用肠道构建的内部储尿囊，配有防漏小开口（常位于脐部）。无需引流袋 — 每日数次经开口插入导尿管排空尿液。

名词解释

尿流改道

膀胱切除或失功能后，引导尿液排出体外的新通路。

造口

腹壁上由肠道形成的小开口，供尿液通过。

导管 (Conduit)

将尿液引至造口的短段肠道（不储存尿液）。

新膀胱 (Neobladder)

由肠道构建并与尿道相连的新储尿囊。

可控性 (Continent)

可防止漏尿 — 由您控制何时排空。

非可控性改道

尿液持续流入引流袋（即回肠膀胱）。

导尿

插入细管引流尿液。

黏液

肠道分泌的滑腻液体；改道后尿液中出现黏液丝属正常现象。

哪种方式最适合我？ 最佳选择取决于您的解剖结构、肾功能、其他健康状况，以及手部灵活度和视力（导尿所需）——同时也与您的生活方式和个人偏好有关。并非每个人都适合所有类型。您的医生会告知哪些选择对您安全可行。

三种方式对比

	回肠膀胱	新膀胱	可控性 (Indiana)
排空方式	自动引流	经尿道排尿	经造口导尿
需佩戴引流袋？	是	否	否
需要导尿？	否	有时需要	始终需要，每4-6小时一次
手术复杂度	最小	较大	较大
日常护理	排空并更换引流袋	定时排尿，全天包括夜间	导尿并冲洗

向医生提问

- 我**适合**哪些选择？您推荐哪种？
- 每种方式的**日常生活**和自我护理是什么样的？
- 对**工作、运动、睡眠和亲密关系**有何影响？
- 主要**风险**是什么？将来需要再次手术的可能性有多大？

三种方式的共同点

- 均使用您**自身的肠道**，因此术后肠道需要数天恢复。
- 尿液中出现**黏液**属正常 — 肠道会分泌黏液。
- 需要**终身随访**，包括定期检查**维生素B12**（该肠段可能导致B12 多年后逐渐下降）。
- **多饮水**，保持尿路通畅。

需要记住的三件事

1. 尿流改道有三种方式 — **腹壁引流袋**（回肠膀胱）、**经尿道排尿**（新膀胱），或**经小开口导尿**（Indiana Pouch）。
2. 三者最大差异在于**日常护理**。最佳选择取决于您的健康状况和个人需求 — 并非每种方式都适合所有人。
3. 三种方式均使用肠道，因此均会出现尿液含黏液、肠道术后恢复数天及终身随访的情况。请阅读您所选方式的专页详情。